

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation



Résumé : RFE SRLF/SFAR (adulte et pédiatrique) sur les stratégies de réduction de l'utilisation curative des antibiotiques en réanimation — 5 questions : résistance/épidémiologie, données microbiologiques, choix de l'antibiothérapie (carbapénèmes, quinolones, anti-SARM), optimisation de l'administration (indication, dosage/TDM, modalités), réévaluation et durée des traitements.

AF

AF = Accord Fort / AF- = Accord Faible — cotation à 2 tours dérivée de RAND/UCLA (échelle 1-9, médiane + intervalle de confiance, 3 zones accord/indécision/désaccord). Le texte source n'imprime **pas** de grade GRADE numérique par item (contrairement à d'autres RFE de ce corpus) — seule la force verbale « il faut »/« il faut probablement » distingue une recommandation forte d'une recommandation optionnelle, déjà intégrée dans le libellé de chaque ligne. 54 recommandations comportant 74 votes internes (47 Accord Fort + 27 Accord Faible) — condensées ici en 62 lignes, sans jamais fusionner deux niveaux d'accord différents.

Q1 — Résistance bactérienne, consommation d'antibiotiques et épidémiologie

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Il existe de nombreux arguments directs et indirects démontrant la relation entre consommation d'antibiotiques et résistance bactérienne.	AF
2	Il faut utiliser des données françaises d'épidémiologie bactérienne globales et locales ; les sociétés savantes doivent diffuser les données des réseaux de surveillance (dont REARaisin) ; chaque unité/établissement doit disposer de données locales précisant la fréquence des espèces isolées et des résistances par espèce.	AF
3	Il faut mesurer les Doses Définies Journalières (DDJ) d'antibiotiques pour toutes les unités de réanimation, globales et ciblées sur les classes à risque (carbapénèmes, fluoroquinolones notamment).	AF-

Q2 — Données microbiologiques pour un moindre usage des antibiotiques

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Pour une désescalade rapide, il faut réaliser des prélèvements bactériologiques si possible avant toute antibiothérapie.	AF
2a	Dans les PAVM, avant antibiothérapie, il faut probablement réaliser des prélèvements respiratoires avec culture quantitative pour réduire l'exposition aux antibiotiques ; il faut communiquer rapidement au clinicien l'examen microscopique direct d'un prélèvement respiratoire profond.	AF
2b	Sous réserve des critères de qualité du prélèvement : en l'absence de signe de gravité, si l'examen direct est négatif, il ne faut probablement pas débiter d'antibiothérapie probabiliste ; en présence de signes de gravité, il faut probablement débiter une antibiothérapie adaptée à l'examen direct positif.	AF-
3	Dans les 24h suivant le prélèvement, il faut qu'un premier résultat de culture soit rendu.	AF
4	En cas d'hémoculture positive, il faut réaliser l'identification bactérienne et l'antibiogramme directement à partir du flacon d'hémoculture.	AF
5	En cas de culture positive, il faut fournir l'identification bactérienne le plus rapidement possible par spectrométrie de masse, pour une adaptation plus précoce de l'antibiothérapie.	AF-
6	Il faut déterminer et communiquer aux cliniciens les CMI recommandées par le CA-SFM ; il faut probablement, après discussion microbiologiste-clinicien, déterminer les CMI pour des sites infectés particuliers et certaines espèces bactériennes.	AF
7a	Pneumonie communautaire : antigénurie pneumocoque positive → stopper les antibiotiques anti-bactéries intracellulaires ; antigénurie légionelle positive → stopper la bêta-lactamine ; antigénurie légionelle négative → ne pas exclure le diagnostic de légionellose.	AF-
7b	Antigénurie pneumocoque négative → ne pas exclure le diagnostic de pneumopathie à pneumocoque.	AF
8	En cas d'hémoculture positive à cocci Gram positif en amas, il faut utiliser des tests rapides détectant <i>S. aureus</i> et sa sensibilité à l'oxacilline.	AF

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation



Q3a — Impact de la colonisation sur le choix de l'antibiothérapie

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Il ne faut pas prescrire un traitement antibiotique systématique en cas d'identification d'une bactérie dans un prélèvement de colonisation, quel qu'en soit le type (notamment aspiration trachéo-bronchique).	AF
2	En présence de signes de gravité, il faut intégrer la connaissance d'une colonisation à bactérie multi-résistante (BMR), quel que soit le site de prélèvement, dans le choix d'une antibiothérapie probabiliste.	AF-

Q3b — Diminuer l'utilisation des carbapénèmes

Réf.	Recommandation	Cotation
1a	En traitement probabiliste, en cas d'infection bactérienne communautaire suspectée, il ne faut pas prescrire de carbapénème.	AF
1b	Exception : un carbapénème peut être envisagé si le patient a un antécédent (< 3 mois) de colonisation/infection à entérobactérie BLSE ou à <i>P. aeruginosa</i> résistant à la ceftazidime, ET un sepsis sévère ou choc septique.	AF-
2	En traitement probabiliste, en cas d'infection bactérienne sévère associée aux soins/nosocomiale suspectée, il ne faut pas prescrire de carbapénème sur le seul critère du caractère nosocomial de l'infection.	AF
3	Après documentation bactériologique, il faut rechercher une alternative aux carbapénèmes selon le site infecté, après discussion entre microbiologistes et cliniciens.	AF

Q3c — Diminuer l'utilisation des quinolones

Réf.	Recommandation	Cotation
1a	Il ne faut pas prescrire de fluoroquinolones (FQ) quand d'autres antibiotiques peuvent être utilisés ; exceptions possibles : légionelloses graves prouvées (association macrolide/rifampicine), infections osseuses/pied diabétique après antibiogramme.	AF-
1b	Exception : prostatites, après antibiogramme.	AF
2	Il ne faut pas prescrire de FQ de façon répétée chez un même patient (prendre en compte les prescriptions antérieures de FQ dans les 6 mois précédents, quelle qu'en soit l'indication).	AF
3	Il ne faut pas prescrire en probabiliste de FQ en monothérapie dans les infections nosocomiales sévères.	AF
4	Il ne faut pas prescrire de FQ sur des souches d'entérobactéries ayant acquis une résistance de premier niveau (acide nalidixique et/ou pipémidique).	AF
5a	Dans le choc septique, en cas d'association avec une bêta-lactamine, il faut préférer les aminosides plutôt qu'une FQ.	AF
5b	... y compris chez l'insuffisant rénal.	AF-

Q3d — Diminuer l'utilisation des anti-SARM — Traitement probabiliste

Réf.	Recommandation	Cotation
P1	Il ne faut pas utiliser les anti-SARM dans le traitement probabiliste des infections communautaires vraies.	AF
P2	Il faut prendre en compte la possibilité d'un SARM dans les infections sévères associées aux soins (patients hémodialysés chroniques, porteurs de plaies chroniques...).	AF
P3	Il faut utiliser les anti-SARM selon l'épidémiologie locale du service pour le traitement probabiliste des infections nosocomiales acquises en réanimation.	AF

Traitement documenté

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation



Réf.	Recommandation	Cotation
D1	Il ne faut probablement pas traiter une hémoculture isolée à staphylocoque blanc (SE), résistant ou non à l'oxacilline ; devant plusieurs hémocultures positives à SE résistant à l'oxacilline (SEMR), il faut probablement changer les cathéters centraux/artériels et décider d'un traitement selon la gravité, l'immunodépression et l'antibiotype.	AF
D2	Sauf chez les patients immunodéprimés, il ne faut probablement pas mettre en route un traitement anti-SARM devant la présence à concentration significative de SEMR dans une PAVM.	AF
D3	Il faut probablement utiliser la daptomycine à fortes doses dans les endocardites ou septicémies à SARM ayant une CMI à la vancomycine > 1 mg/L.	AF-
D4	Il faut probablement utiliser le linézolide dans les PAVM à SARM.	AF
D5	Il faut probablement réaliser une CMI du SARM à la vancomycine ; en l'absence d'amélioration clinique après 3 jours pour une infection à SARM de CMI > 1 mg/L, il faut probablement utiliser une alternative à la vancomycine.	AF
D6	Il faut probablement discuter, selon le site infecté, l'intérêt d'une association anti-SARM.	AF-

Q4a — Indication formelle de l'antibiothérapie

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Choc septique : il faut administrer une antibiothérapie probabiliste dans l'heure suivant la survenue du choc.	AF
2	Suspicion de pneumonie communautaire sévère : il faut probablement envisager d'autres diagnostics avant toute antibiothérapie, dans un délai maximal de 4h après l'admission, pour éviter une prescription inutile.	AF-
3	Méningite bactérienne : il faut administrer les antibiotiques dans les 3h après l'admission à l'hôpital, idéalement dans l'heure.	AF
4	Il faut probablement raccourcir au maximum le délai d'administration de la 1ère dose chez les patients « fragiles » (splénectomisé fébrile, neutropénique fébrile, dermo-hypodermite bactérienne nécrosante...).	AF

Q4b — Dosage des antibiotiques (TDM)

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Chez tout patient sévère (adulte ou pédiatrique) de réanimation, du fait d'une variabilité pharmacocinétique importante et imprévisible, il faut faire des dosages de certains antibiotiques.	AF
2	Il faut doser le pic plasmatique d'aminoside 30 min après la 1ère dose (perfusion en 30 min) chez tout patient sévère ; une concentration inférieure à l'objectif attendu doit entraîner une augmentation de la dose suivante.	AF-
3	Il faut un dosage de la concentration résiduelle d'aminoside pour éviter toute toxicité d'une réinjection trop précoce, a fortiori en cas d'insuffisance rénale.	AF-
4	Chez l'adulte comme chez l'enfant, il faut doser la concentration de vancomycine à l'équilibre (perfusion continue après dose de charge) ou en résiduelle (perfusion discontinue).	AF
5	Il faut probablement mesurer la concentration de certaines bêta-lactamines à large spectre, en résiduelle (administration discontinue/prolongée) ou à l'équilibre (perfusion continue).	AF-

Q4c — Modalités d'administration des antibiotiques

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Infections sévères en réanimation : il faut probablement maintenir les concentrations plasmatiques de bêta-lactamines $\geq$ CMI pendant au moins 70 % du temps pour garantir le succès thérapeutique.	AF-
2	Il faut probablement viser un objectif plus élevé (Cmin/CMI > 4-6) dans certaines situations.	AF

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation



Réf.	Recommandation	Cotation
3	En réanimation, pour les infections sévères (a fortiori si CMI élevées), il faut probablement administrer les bêta-lactamines (céfépime, pipéracilline-tazobactam, méropénème...) en perfusion prolongée/continue.	AF
4a	Il ne faut probablement pas administrer systématiquement les bêta-lactamines en perfusion continue, malgré un avantage théorique démontré en pharmacocinétique.	AF-
4b	Il faut probablement réserver cette modalité (carbapénèmes méropénème/doripénème, ceftazidime, pipéracilline-tazobactam) au traitement des infections sévères à risque d'échec pharmacodynamique (foyers profonds, pharmacocinétique altérée, CMI élevées).	AF-
5	Il faut probablement administrer la vancomycine en perfusion continue, après dose de charge, pour obtenir plus rapidement les concentrations cibles.	AF
6	Il faut probablement utiliser des modalités d'administration prolongée/continue pour prévenir l'émergence de résistance bactérienne (certaines souches).	AF-

Q4d — Associations d'antibiotiques

Réf.	Recommandation	Cotation
1	En l'absence de facteur de risque de BMR, il faut traiter en probabiliste les pneumopathies nosocomiales en monothérapie.	AF-
2	Il faut traiter par une association probabiliste les patients en état de choc, neutropéniques, ou suspects d'infection à BMR.	AF

Q5 — Réévaluation et durée des traitements antibiotiques

Réf.	Recommandation	Cotation
1	Il faut une réévaluation de l'antibiothérapie chez tous les patients de réanimation au plus tard à 48-72h, avec désescalade selon la situation clinique et les données microbiologiques.	AF
2a	Procalcitonine (PCT) : il faut probablement l'utiliser pour guider l'interruption des antibiotiques (notamment infections respiratoires basses) — PCT < 0,5 ng/mL ou baisse > 80 % du pic → antibiothérapie peut être arrêtée.	AF-
2b	Il faut probablement mettre en place des recommandations locales structurant cette réévaluation pour réduire l'exposition aux antibiotiques.	AF
2c	Il faut probablement doser la PCT toutes les 48-72h au-delà de J3 pour réduire la durée de l'antibiothérapie.	AF-
3	PAVM chez un patient non immunodéprimé, antibiothérapie initiale adaptée : il faut limiter la durée totale de l'antibiothérapie à 8 jours.	AF-
4	En dehors de situations cliniques particulières, il faut probablement limiter à 5-7 jours le traitement d'une infection communautaire.	AF
5	En dehors d'une bactériémie à <i>S. aureus</i> ou compliquée de métastases infectieuses, il faut probablement limiter à 5-7 jours le traitement d'une bactériémie liée au cathéter si les hémocultures se négativent.	AF
6	Il faut probablement mettre en place une concertation pluridisciplinaire pour améliorer l'adéquation des antibiothérapies, augmenter le taux de désescalade et limiter leur consommation.	AF
7	Il faut probablement mettre en place des protocoles d'antibiothérapie pour améliorer le pronostic des patients et limiter l'émergence de résistances.	AF

Sources et avertissement

SRLF/SFAR, avec GFRUP/SFM/SPILF/SF2H, « Stratégies de réduction de l'utilisation des antibiotiques à visée curative en réanimation (adulte et pédiatrique) », RFE, Juin 2014. Méthode GRADE + cotation RAND/UCLA à 2 tours. 228 références bibliographiques citées dans le texte intégral (non reproduites ici) ; composition nominative du groupe d'experts (non reproduite).

Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation



Réduction de l'utilisation des antibiotiques en réanimation

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les 74 votes du texte source (condensés en 62 lignes, sans jamais fusionner deux niveaux d'accord différents) mais condense l'argumentaire de chaque item et omet la composition nominative du groupe d'experts. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SRLF/SFAR.